

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL
DE AMARGOSA / BA

CARGO 025
TÉCNICO DE SUPORTE À SAÚDE -
TERAPIA OCUPACIONAL

INSTRUÇÕES

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**, de acordo com o enunciado. Para cada questão, há, na **folha de respostas**, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher apenas o correspondente à resposta julgada correta, conforme o enunciado da questão.

O candidato transcreverá as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas e procederá em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

O candidato marcará, obrigatoriamente, para cada questão, um, e somente um, dos cinco campos da folha de respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. As marcações indevidas são da exclusiva responsabilidade do candidato, que sofrerá os prejuízos decorrentes do preenchimento indevido da folha de respostas.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**.

É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Confira atentamente seus dados pessoais, em especial o nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade e sua data de nascimento.

Caso eles não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.

Não é permitido que outras pessoas façam as marcações na folha de respostas.

Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início da prova e poderá levar seu caderno de prova somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação da sua prova.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefamargosa>, no dia 28/11/2006, a partir das 15 horas.



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A terapia ocupacional desenvolve suas ações nos contextos hospitalares das intervenções voltadas para as consequências da enfermidade e da própria internação hospitalar, bem como para as alterações e rupturas que acometem os seres humanos. Seu objetivo primordial é a promoção da qualidade de vida do sujeito hospitalizado. Dimensiona soluções para a permanência no ambiente hospitalar, para a melhoria das relações com a equipe profissional e para o atendimento das necessidades da família e / ou do acompanhante. Considerando os objetivos terapêuticos e as capacidades do profissional no contexto hospitalar, relacione a coluna de cima com a coluna de baixo.

- I – Promoção da melhoria das relações interpessoais no cotidiano hospitalar e suas interfaces com a família e a equipe.
 - II – Atuação com base no uso específico de atividades, que podem ser artesanais, profissionais e artísticas, de autocuidado e/ou de acompanhamento.
 - III – Ligação intrínseca do processo terapêutico-ocupacional às diferentes formas de refletir sobre a ação humana, baseadas em diferentes processos, fundamentos ou bases filosóficas, como um dos princípios fundamentais.
- () abordagem holística no processo de recuperação funcional
 () fundamentação teórico- metodológica
 () desenvolvimento de programas de assistência
 () recursos terapêuticos ocupacionais
 () facilitação da inter-relação equipe/paciente.

A seqüência correta é

- (A) III II II I III.
- (B) III II II I I.
- (C) II I II II III.
- (D) I III II II I.
- (E) I II I III I.

02. Com relação aos procedimentos de avaliação em terapia ocupacional, é correto afirmar que

- I – entrevistas, questionários, técnicas de medida, e de observação e amostragem fazem parte dos procedimentos para obter informação.
- II – a avaliação pode ser formal ou informal.
- III – é raro observar um paciente realizar tarefas em ambientes domésticos, de trabalho ou comunitários.
- IV – o processo de avaliação envolve: aquisição de informação, observação, mensuração, registro e reavaliação de resultados.

V – a análise das ocupações e sua prescrição como terapia não são habilidades únicas da terapia ocupacional.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I, III e V.
- (B) I, II e IV.
- (C) I e V.
- (D) II e III.
- (E) III e V.

Leia o texto abaixo e responda às questões 03 e 04.

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica, progressiva, sem remissão e de condições altamente variáveis. Nos estágios tardios da DP, o sofrimento psíquico leva à redução da qualidade de vida e à instalação de incapacidades funcionais.

03. Em relação à DP, assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – Está relacionada às doenças neurodegenerativas.
- II – A falta dos reflexos posturais em geral resulta em quedas numerosas e acinesia.
- III – A ocorrência é mais comum nos primeiros anos de vida adulta.
- IV – A abordagem terapêutico-ocupacional é solicitada nos estágios intermediários e finais da doença, quando são observados sintomas de limitações funcionais e incapacidades.
- V – O isolamento social e a aposentadoria precoce raramente ocorrem como problemas psicossociais enfrentados pelo paciente.

A seqüência correta é

- (A) V F V F V.
- (B) V F F V V.
- (C) F V V F V.
- (D) V V F V F.
- (E) F V F V V.

04. Na DP, a primeira queixa apresentada é

- (A) dor.
- (B) demência.
- (C) tremor.
- (D) edemas.
- (E) face em máscara.

05. Em um paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral, são geralmente identificadas as seguintes deficiências motoras:

- (A) afasia e paraparesia.
- (B) hemiplegia e hemiparesia.
- (C) monoplegia e diplopia.
- (D) paraplegia e afasia.
- (E) monoparesia e diplopia.

06. Na observação das doenças neurológicas, encontramos uma variedade de patologias, disfunções físicas e incapacidades funcionais relacionadas ao trabalho, aos autocuidados e ao lazer, que levam o terapeuta ocupacional a abordar de maneira holística estes aspectos em busca da qualidade de vida do indivíduo. Identifique a opção em que há uma patologia neurológica.

- (A) Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
- (B) Síndrome do Túnel do Carpo
- (C) Fratura de Quadril
- (D) Artrite Reumatóide
- (E) Transtorno Obsessivo-Compulsivo

07. Conhecida como a “paralisia dos amantes”, na qual observamos comumente a compressão do nervo na goteira umeral, resultante de fraturas, luxação de ombro ou compressões por muletas; caracterizada por pronação do antebraço, incapacidade para extensão do punho, fraqueza de preensão conseqüente à queda do punho: esta descrição constitui paralisia de nervo periférico denominada paralisia

- (A) cubital.
- (B) do nervo femural.
- (C) do nervo mediano.
- (D) radial.
- (E) do ciático popliteu externo.

Leia o texto e responda as questões de 08 a 10.

No campo da reabilitação ortopédica e traumatológica, o objetivo maior do terapeuta ocupacional é auxiliar o paciente a explorar seus potenciais funcionais máximos, restaurando sua função, habilitando-o ou reabilitando-o na apresentação de disfunções ou incapacidades físicas. Entre os vários recursos e procedimentos terapêutico-ocupacionais que visam à recuperação física funcional e ocupacional, o terapeuta ocupacional obtém a melhoria da qualidade e das condições emocionais, além de promover a inserção social de seu paciente.

08. De acordo com o texto, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F)

- I – O terapeuta ocupacional visa, entre outros objetivos, à prevenção de incapacidades, ao ganho de amplitude de movimento e força, e à reeducação sensitiva nas afecções musculoesqueléticas.
- II – O terapeuta ocupacional estabelece com o paciente, a família e a equipe multiprofissional um plano de tratamento que ajude a evitar o agravamento do quadro biopsicossocial.
- III – O controle do edema e o manuseio da cicatriz em pacientes submetidos a cirurgias de membros superiores fazem parte dos

procedimentos do terapeuta ocupacional na reabilitação ortopédica e traumatológica.

- IV – Na recuperação cirúrgica, as órteses e as adaptações só podem ser utilizadas após o processo total de cicatrização da área afetada.
- V – A forma como o paciente lida com a incapacidade e as reações ao trauma são fatores emocionais de ordem interna que influenciam o processo de reabilitação.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II, III e V.
- (E) III, IV e V.

09. Marque a opção correta.

- (A) A imobilização é uma categoria de tratamento para tendões reconstruídos que preconiza, em seus protocolos, a mobilização ativa e a passiva logo no início do pós-cirúrgico.
- (B) As orientações de manutenção de independência nas AVD (Atividades de Vida Diária) para pacientes amputados de músculos superiores só devem ser iniciadas após a alta hospitalar.
- (C) O complexo do ombro é a mais móvel de todas as articulações, sendo considerado a porção do corpo mais desafiadora para a reabilitação.
- (D) A imobilização do ombro não resulta em rigidez e dor, portanto, o movimento ativo do ombro nas fraturas estáveis só é iniciado após quatro semanas de tratamento.
- (E) No estágio agudo da reabilitação ortopédica, o treino de AVD (atividades de vida diária – banhar-se, escovar os dentes, alimentar-se, entre outras) precisa de autorização médica.

10. Atualmente, a saúde mental é discutida de forma mais intensa, considerando a exacerbação de sintomas ligados às doenças relacionadas ao trabalho, ao estresse do cotidiano e ao afastamento afetivo da família. Dentro do quadro das doenças mentais, salientam alguns sintomas fundamentais de dissociação do pensamento, distúrbios afetivos, ambivalência e características autistas, com sintomas acessórios de alucinações e delírios. Estes sintomas iniciam na adolescência, desenvolvendo-se em curto período, de dias ou meses. Assinale a opção que corresponde aos sintomas acima descritos.

- (A) mania
- (B) depressão
- (C) transtorno obsessivo compulsivo (TOC)
- (D) esquizofrenia
- (E) transtorno bipolar do humor

11. No desenvolvimento neuropsicomotor do bebê de quatro meses, existem padrões que determinam seu grau de desenvolvimento motor fino e de adaptação ao meio, bem como da linguagem e do contato social. Esta é uma fase em que muitos padrões tônicos posturais, reflexos e reações começam a se estabilizar, levando o bebê a experimentar ativamente o seu ambiente e iniciar os primeiros contatos sociais. Com base no texto, assinale a opção em que é descrito o padrão motor normal do bebê de quatro meses.

- (A) Vira-se de ambos os lados para a posição ventral; tem bom controle de cabeça; vira-se em círculo em torno do próprio eixo; fletindo-se, passa à posição de engatinhar; quadril em rotação externa; pernas movem-se livremente; ergue-se apoiado em objetos e fica em pé; ainda tem reflexo de preensão.
- (B) Em decúbito dorsal, apresenta posição simétrica e vira-se para os dois lados; as mãos são trazidas à linha média do corpo, sendo capaz de segurar um objeto; pernas em rotação externa abduzidas; joelhos em flexão, mas são estendidos; pés dorsifletidos; quando a cabeça se move, ainda apresenta reação de Moro, incompleta, só abrindo as mãos.
- (C) Postura flexora; cabeça colocada de lado; corpo segue rotação em bloco; mãos em pronação, às vezes abertas, outras, fechadas; pernas afastadas do quadril em rotação externa; apresenta reação tônico-cervical assimétrica e reação de Moro.
- (D) Vira-se da posição dorsal para a ventral, para ambos os lados; pode pegar nos pés e apalpar o corpo para reconhecê-lo; estende os braços e arqueia a cabeça; boa abdução de quadril; pernas em rotação externa, abduzidas em flexão; os movimentos são coordenados.
- (E) Quase nunca fica nas posições dorsal e ventral; pode apoiar-se para a frente e para o lado, mostrando boa rotação de tronco; levanta-se segurando objetos; boa estabilidade em pé e bom equilíbrio; dá os primeiros passos com apoio.

12. Diante de uma internação de uma criança, faz-se necessário organizar as atividades do cotidiano. Segundo a concepção winnicottiana, a questão não é o fato de a criança estar no hospital, mas de como ela pode viver sua história pessoal de modo saudável para o desenvolvimento, situação em que o terapeuta ocupacional busca estabelecer relação de confiança, para desenvolver seu programa de tratamento. Identifique a opção em que ambas as intervenções terapêutico-ocupacionais ocorrem durante a hospitalização infantil.

- (A) O brincar e a administração de medicamentos.
- (B) A observação e a análise do processo de adaptação hospitalar, e a visita domiciliar.

- (C) A observação da relação mãe-filho e o estabelecimento de comunicação com a criança (toque, brincar etc.).
- (D) A instrumentalização sobre desenvolvimento infantil e os procedimentos invasivos.
- (E) A administração de medicamentos e a visita domiciliar.

13. O envelhecimento representa a consequência ou os efeitos da passagem do tempo, observados nas dimensões biológica e psíquica do indivíduo, tendo importância na medida em que são coadjuvantes para a manutenção da autonomia e da independência. Considerando que o envelhecimento biológico é dinâmico, inexorável e irreversível, relacione a coluna de cima com a de baixo.

- I – Refere-se aos processos biológicos inerentes aos organismos que são inevitavelmente involutivos.
 - II – Refere-se a alterações resultantes de traumas e doenças que ocorrem no ciclo vital.
 - III – Abrange todas as funções do corpo, atividades e participação.
 - IV – Abrange deficiências, limitação de atividades ou restrição na participação.
- () incapacidade
 - () envelhecimento fisiológico (senescência)
 - () envelhecimento patológico (senilidade)
 - () envelhecimento isento de danos causados por hábitos de vida
 - () funcionalidade

A sequência correta é

- (A) I III II IV III.
- (B) I VI II III II.
- (C) III I II II IV.
- (D) III II I I IV.
- (E) IV I II I III.

14. Identifique a opção que contém a patologia cujo diagnóstico é de difícil conclusão, e cujo tratamento, muitas vezes paliativo, necessita da abordagem do terapeuta ocupacional desde a confirmação do diagnóstico, pois 80 % dos casos chegam à internação no 1.º ano de doença.

- (A) Doença de Parkinson
- (B) seqüelas decorrentes de doenças crônico-degenerativas, como o diabetes e as neoplasias
- (C) Doença de Alzheimer
- (D) acidente vascular cerebral (AVC)
- (E) internações cirúrgicas por fraturas

15. Como sabemos, a principal função da órtese é otimizar o aparelho locomotor por meio da força externa, para influenciar a mobilidade articular, protegendo estruturas reparadas, mantendo ou aumentando a amplitude de movimento, melhorando a qualidade de um

movimento ou substituindo a ação muscular. Seus princípios anatômicos estão relacionados aos ossos, às articulações, aos ligamentos, aos arcos e à pele, portanto, o uso na abordagem terapêutica ocupacional é recurso importante para a recuperação funcional do paciente. Segundo a classificação e objetivos das órteses, relacione a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa correta.

- I – órtese estática
- II – órtese estática seriada
- III – órtese estática progressiva
- IV – órtese dinâmica
- V – órtese articulada

- () Posicionada por um longo período de tempo, é bastante eficaz em articulações e tem movimento limitado quando há significativa resistência no final do movimento.
- () Componente móvel posicionado paralelamente ao eixo da articulação, tem também a função de imobilizar com o travamento da dobradiça.
- () Utilizada para promover o alongamento tecidual, é moldada em comprimento máximo, por longo período de tempo, e remodelada à nova condição estrutural.
- () Proporciona repouso articular, protege estruturas após a reparação cirúrgica, promove o controle de edema e previne deformidades esqueléticas.
- () Iniciando um movimento passivo e utilizando a força de deformação por meio de tração intermitente a uma articulação, possui fonte de energia autônoma (baterias ou eletricidade).

A sequência correta é

- (A) I V II III IV.
- (B) II I V IV III.
- (C) III V II I IV.
- (D) IV III I II V.
- (E) III II I V IV.

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 16 a 19.

Texto I

Os santos do capitalismo

No Brasil, quase não há facilidades fiscais para estimular as doações e ações de filantropia. Na verdade, sobram dificuldades. Segundo um estudo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento

Social (Idis), 20% da população economicamente ativa faz algum tipo de doação, cujo valor médio é equivalente a um salário mínimo por ano. “É um milagre, se considerarmos que não há quase nenhum incentivo para isso”, diz Marcos Kisil, presidente do Instituto. Como pessoa física, o brasileiro consegue abater no máximo 6% do que deve ao imposto de renda, se fizer doações para os conselhos municipais, estaduais e federais dos direitos da criança e do adolescente, que são os controladores dos fundos beneficiados pelas doações. A legislação para empresas e fundações é um pouco mais flexível – dependendo da área de atuação ou do tipo de doação, pode até haver a isenção tributária total.

Revista **Veja**, 5 de julho, 2006. p. 68–69.

16. De acordo com o texto I, é correto afirmar que, no Brasil,

- (A) sobram estímulos à distribuição de recursos para filantropia.
- (B) mais da metade da população total faz doações acima de um salário mínimo por ano.
- (C) as doações para o setor público geram bons abatimentos no imposto de renda.
- (D) a legislação do setor privado autoriza, em certos casos, a isenção plena de impostos.
- (E) com tanta facilidade, é uma surpresa que mais pessoas não façam doações para a filantropia.

17. No texto I, a palavra “filantropia” NÃO pode ser entendida como

- (A) assistencialismo.
- (B) caridade.
- (C) beneficência.
- (D) humanitarismo.
- (E) dadivosidade.

18. A propósito da pontuação do texto I, assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – Na linha 1, o uso da vírgula é obrigatório depois de “No Brasil”, para indicar o deslocamento da expressão para o início da oração.
- II – Na linha 5, o emprego de parênteses isola a sigla da instituição realizadora de pesquisa descrita no texto.
- III – Nas linhas 7 e 9, o emprego de aspas marca o discurso direto, isto é, a citação literal das palavras do presidente do Instituto.
- IV – Na linha 14, o emprego da vírgula é obrigatório porque a oração seguinte, iniciada por “que”, tem sentido restritivo.
- V – Na linha 17, o uso de travessão serve para destacar, enfaticamente, a parte final do enunciado.

A sequência correta é

- (A) F V F F F.
- (B) F V F V F.
- (C) V F V V F.
- (D) F F V V V.
- (E) V V V F V.

19. De acordo com o texto I, marque a única opção correta.

- (A) Na linha 1, a forma verbal “há” pode ser substituída por **existe**.
 (B) Na linha 3, “Segundo” é um numeral ordinal.
 (C) Na linha 6, falta o artigo definido **o** depois de “cujo”.
 (D) Na linha 9, “do” é a fusão da preposição **de** com um pronome demonstrativo.
 (E) Na linha 11, o pronome relativo “que” refere-se a “direitos da criança e do adolescente”.

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 20 a 22.

Texto II**Do caderno de um peripatético**

Andando, ouve-se uma frase aqui, outra ali adiante. A questão é ter paciência, uma paciência muito atenta e meio distraída, como se fosse numa pescaria. E como a rua que vou descendo se chama casualmente Rua da Praia, aqui te dou de presente este lambari que acabo de fisgar de passagem:

– Mamãe, motociclo corre mais do que bicicleta?

Não ouvi resposta nenhuma da bela dama que levava o menininho pela mão: as mães nem sempre adivinham tudo.

Mario Quintana. “Caderno H”. In: **Obra Completa**. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2005. p. 346.

20. De acordo com o texto II,

- (A) as frases andam junto com os observadores e logo os ultrapassam.
 (B) o narrador estava a caminho de uma pescaria.
 (C) a direção em que o narrador andava era de cima para baixo.
 (D) a mãe do menininho recebeu de presente do narrador o peixe que ele acabara de pescar.
 (E) o escritor Mario Quintana, famoso morador de Porto Alegre, era freqüentador assíduo das pescarias na Rua da Praia.

21. O texto II relata uma situação de obscuridade lingüística, porque

- (A) a mãe do menininho era bela, mas não era escolarizada.
 (B) a bela dama não sabia que motociclo é uma bicicleta motorizada.
 (C) a mulher não ouviu a pergunta do filho.
 (D) a mãe não gostou da adivinhação proposta pelo menininho.
 (E) as mães têm sempre uma resposta para as dúvidas das crianças.

22. A propósito dos aspectos gramaticais do texto II, marque a única opção INCORRETA.

- (A) A forma verbal no gerúndio “Andando” (l. 1) expressa uma ação em curso, realizada imediatamente antes da indicada na oração principal.
 (B) O vocábulo “como” empregado na linha 3 tem valor comparativo, enquanto o “como” que ocorre na linha 4 tem sentido causal.

- (C) O emprego proclítico do pronome átono em “se chama” (l. 4) fere a norma culta do português contemporâneo usado no Brasil.
 (D) O emprego de **alguma**, em vez de “nenhuma” (l. 8), é considerado gramaticalmente correto.
 (E) O sinal de dois pontos (l. 9) introduz um esclarecimento do que foi enunciado antes.

23. Um hotel de uma região turística vai renovar as cúpulas dos abajures em 20 apartamentos, cobrindo a parte externa de cada um com tecido. As cúpulas têm forma cilíndrica, com 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura. Cada apartamento tem dois abajures. Quantos metros quadrados de tecido serão necessários para realizar o trabalho? (Considere $\pi = 3$.)

- (A) 7
 (B) 12
 (C) 14,4
 (D) 144
 (E) 1.440

24. João é um médico pneumologista. Ele está desenvolvendo uma campanha antifumo que levará aos colégios da sua região de trabalho. Como parte da campanha, quer demonstrar o grande número de mortes entre os fumantes. Por isso, levantou os seguintes dados:

Causa da Morte	Taxa de Mortalidade entre Fumantes	Taxa de Mortalidade entre Não-Fumantes
Doenças do Coração	1.380	860
Câncer de Pulmão	350	22
Outros	1.659	1.446

De acordo com as informações acima, qual foi o aumento percentual para cada uma das três causas de morte mencionadas, comparando-se as taxas de mortalidade entre fumantes e não-fumantes?

- (A) 6 – 1,5 – 16
 (B) 6 – 15 – 16
 (C) 6 – 150 – 1,6
 (D) 60 – 150 – 16
 (E) 60 – 1.500 – 16

25. A tabela a seguir é uma matriz que representa os acidentes de trânsito com vítimas de uma grande cidade do Brasil, registrados nos três primeiros meses de certo ano, durante os finais de semana.

	JAN	FEV	MAR
Sexta	1.840	2.054	2.487
Sábado	1.777	1.968	2.347
Domingo	1.584	1.872	2.309

Sendo b_{ij} um elemento qualquer desta matriz, onde “i” representa a posição linha e “j” a posição coluna do elemento b_{ij} , é correto afirmar que:

- (A) A média dos acidentes ocorridos em março nos finais de semana foi de 2.381.
- (B) A mediana dos acidentes ocorridos aos sábados, durante os meses considerados, foi o acidente de número 2.031, ocorrido no mês de março.
- (C) A tabela acima é uma matriz quadrada que não possui um determinante associado a ela.
- (D) b_{11} , b_{21} e b_{31} , quando somados, representam a média dos acidentes de trânsito ocorridos em janeiro.
- (E) b_{22} é a moda dos acidentes de fevereiro ocorridos durante os sábados.

26. Durante o trabalho num campo de flores, uma abelha operária disse a outra: “Se eu te passar um dos potes de pólen que carrego, ficaremos com cargas iguais; mas, se você me passar um dos potes que carrega, minha carga ficará sendo o dobro da sua”. Supondo que todos os potes sejam iguais, se a quantidade de potes carregados pela primeira abelha é P e pela segunda abelha é Q, quanto vale o produto (P.Q)?

- (A) 12
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 32
- (E) 35

27. A região de Amargosa, servindo de ponto de troca com o sertão, alcançou a elevação de Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho das Amargosas, em 1878, durante o Império, à categoria de cidade de Amargosa, em 1891, já na República. A economia responsável pelo desenvolvimento da região estava ligada à produção de

- (A) açúcar.
- (B) fumo e café.
- (C) cacau.
- (D) ouro.
- (E) borracha.

28. ECONOMIA: Produção Agropecuária – A pecuária extensiva é a marca do médio e grande produtor, sendo que a pecuária de leite intensiva, inserida no contexto dos anos 1970, tinha se mostrado como alternativa, tem passado por grandes dificuldades devido ao custo dos insumos. Atualmente, a maioria da população ativa em Amargosa está inserida no setor primário, produzindo na agricultura as culturas de subsistência e

tendo a mandioca como a mais importante, com ênfase para banana, milho, feijão, fumo e amendoim, que são o sustentáculo da pequena produção. No cacau, café e cana encontra-se a alternativa da pequena e da média produção.

Fonte: <http://www.amargosa.ba.gov.br/infra.htm>

Segundo o texto, a respeito da produção agropecuária de Amargosa hoje, é INCORRETO afirmar que

- (A) o alto custo dos insumos dificulta a pecuária intensiva do leite.
- (B) são produzidos na região, principalmente, nove produtos agrícolas.
- (C) a produção agrícola destina-se ao auto-sustento da população.
- (D) a mandioca se destaca, entre as principais culturas da região.
- (E) a população economicamente ativa se insere no setor de serviços.

29. O geógrafo Milton Santos afirma que “o transporte é um sério problema regional e é responsável pela grande expressão da feira de Amargosa”. Para ele,

- (A) o problema do transporte é simples e recente na região de Amargosa.
- (B) somente se encontram problemas do transporte em Amargosa.
- (C) Amargosa é responsável pelo problema do transporte.
- (D) a relevância da feira de Amargosa decorre do problema de transporte.
- (E) só a geografia explica o problema da feira de Amargosa.

30. “Reduto da História nacional, foi em Porto Seguro, na Bahia, que a nau portuguesa de Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez. [...] Ainda hoje, do vasto litoral ao interior, a Bahia preserva viva a memória do Brasil Colônia, encravada nas ruas de paralelepípedo, nos monumentos erguidos em louvor a santos portugueses, a grandes nomes da cultura e às batalhas históricas à época do descobrimento e da colonização, nas construções seculares [...]”.

“Terra dos orixás, patuás e babalorixás. Terra do culto a Todos os Santos. A Bahia é também a terra de todos os ritos e mitos. As diversas expressões folclóricas sustentam a riqueza do imaginário popular.”

Fonte: <http://www.bahia.com.br/viver>

Nenhum dos textos faz referência a

- (A) aspectos históricos e culturais.
- (B) características arquitetônicas.
- (C) problemas socioeconômicos.
- (D) elementos folclóricos.
- (E) conceitos religiosos.